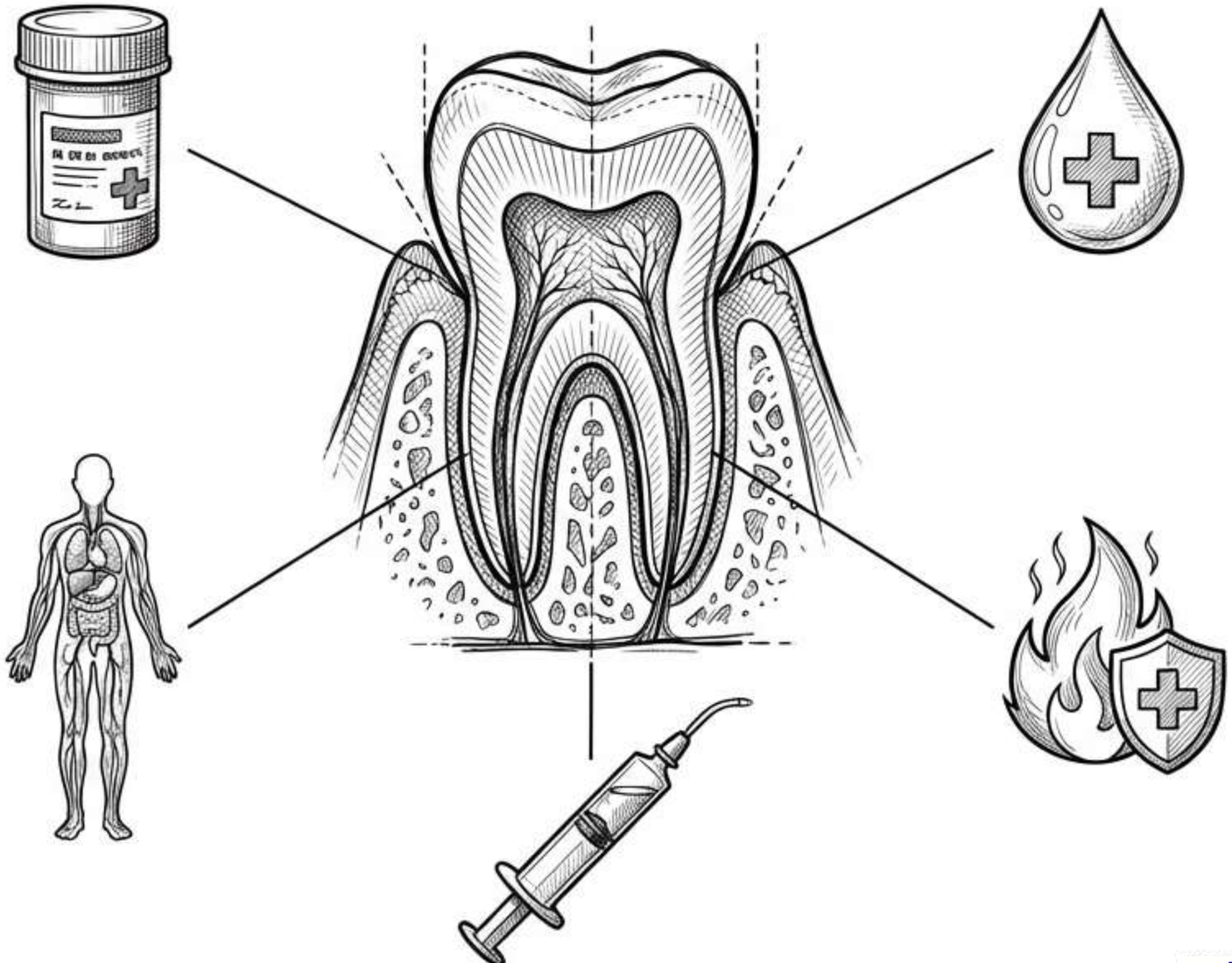
Prescription Médicale en Parodontie

Guide d'Étude Exhaustif & Algorithmes Décisionnels

Structure du Blueprint (Sommaire) :

1. Principes et Modalités de Prescription
2. Justifications & Critères de Choix (Bactériologie, PK, Terrains)
3. Antibiothérapies Systémiques & Locales
4. Anti-Inflammatoires & Antalgiques
5. Antiseptiques & Désinfectants



Dentist Web

1. Introduction & 2. Principes de Prescriptions

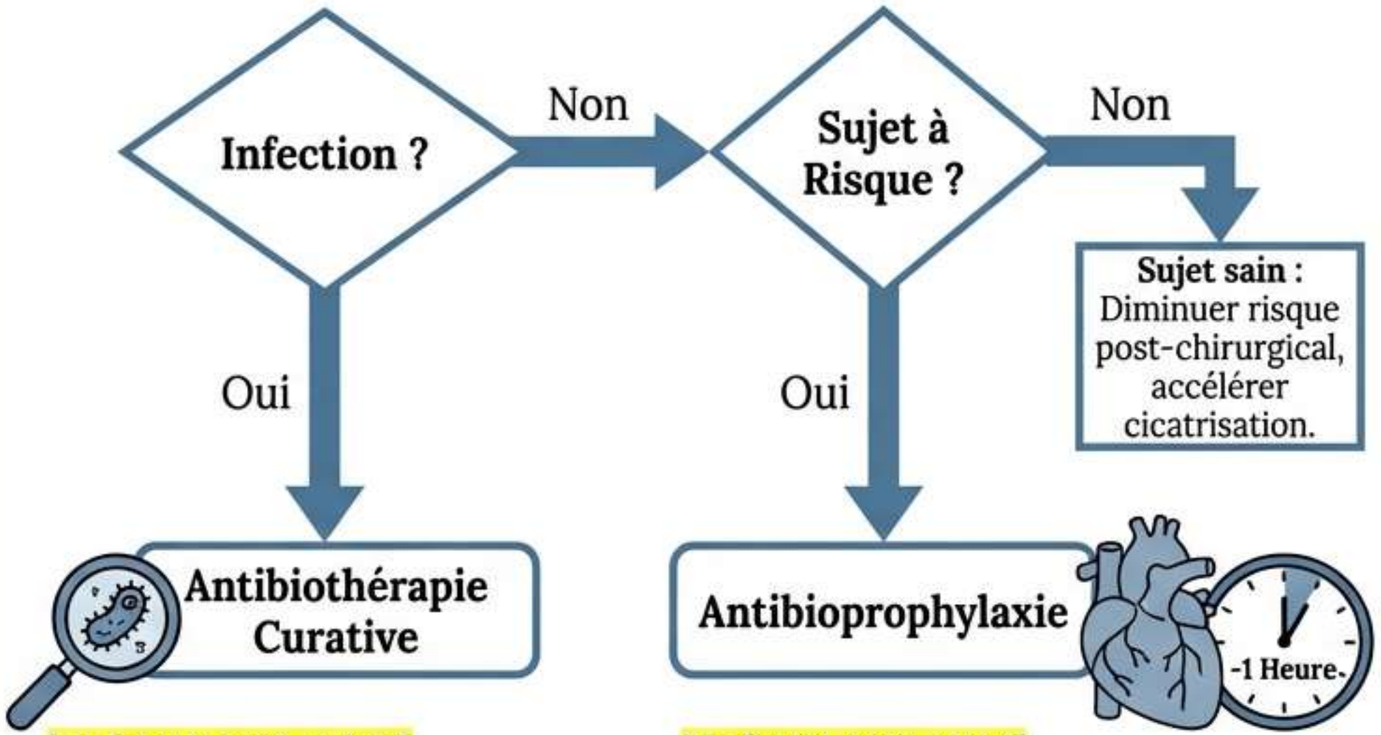
Introduction :

Le succès parodontal repose sur la dépuration mécanique méticuleuse et l'hygiène buccale. Les produits chimiques (antimicrobiens) sont des adjuvants pour les situations difficiles.

Principes de prescription (Règles d'Or) :

- Prescrire uniquement sur indication formelle.
- [Predicted - High probability trap question] **Ne pas substituer un ATB à une chirurgie appropriée.**
- Privilégier le rapport bénéfice/risque le plus favorable.
- Choisir l'ATB au spectre le plus étroit possible.
- Dose et durée suffisantes (éviter sous/surdosage).
- Vérifier les hypersensibilités (allergies).
- Choisir le moins cher à efficacité égale.

Modalités de Prescription :



[Ref: N°2, N°3, N°65]
Indiquée pour traiter une **infection déclarée** (Parodontite agressive, GUN, PUN, Abcès).
Nécessite d'identifier le germe, adapter à l'âge, et choisir entre monothérapie ou association.

[Ref: N°1, N°7, N°14]
Prévenir **l'endocardite bactérienne** (dysfonctionnement valvulaire, prothèse).
Administration d'une dose flash dans l'heure (1h) qui précède l'acte invasif (bactériémie transitoire).

Dentist Web

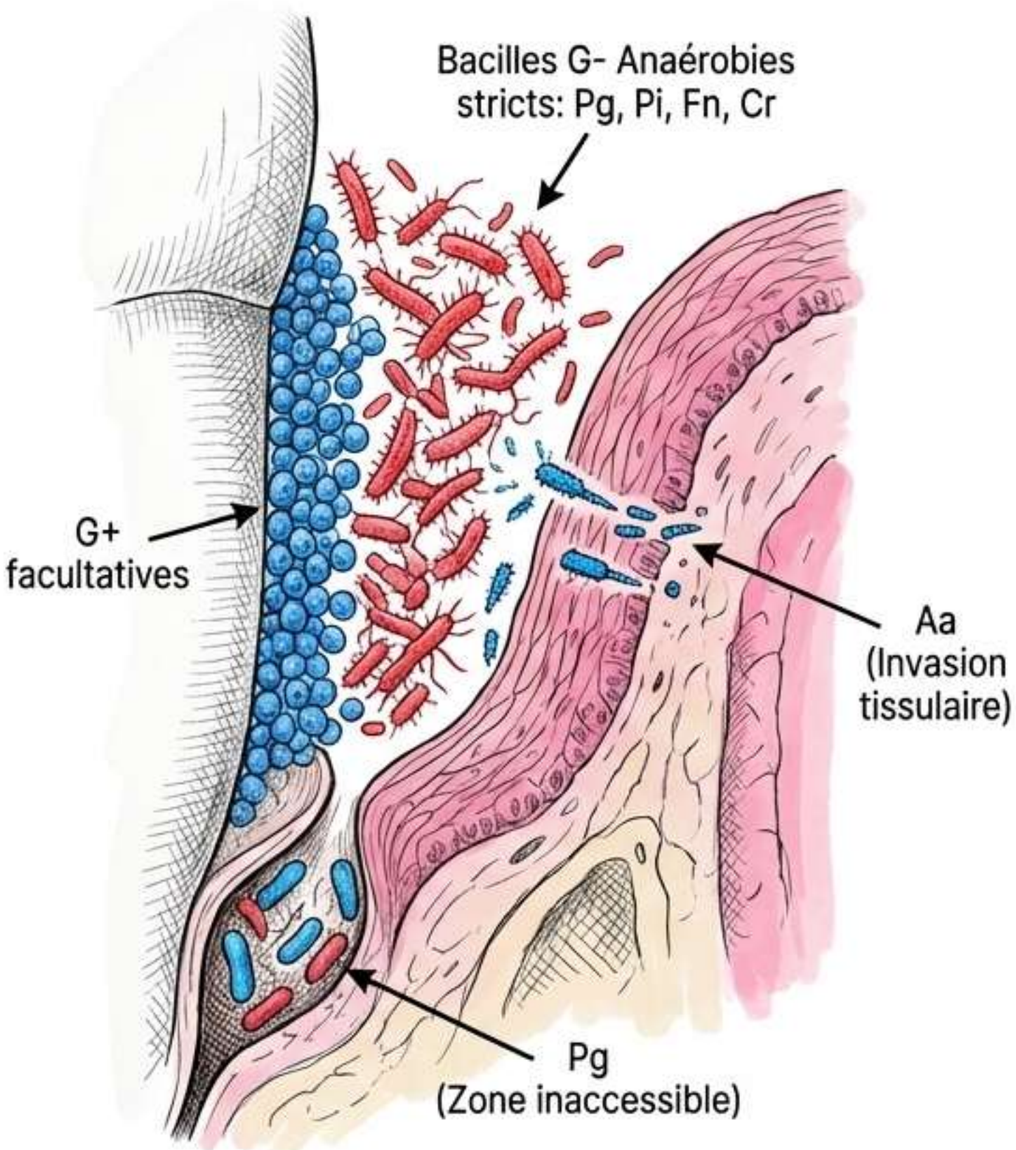
3. L'Antibiothérapie en Parodontie - Justifications Bactériologiques

Justifications Bactériologiques :
- L'efficacité mécanique varie car les pathogènes peuvent s'attacher et envahir les tissus (Ex: *Actinomyces actinomycetemcomitans* - Aa).
- Se cacher dans des zones inaccessibles comme les furcations (Ex: *Porphyromonas gingivalis* - Pg).
- Résister grâce à des troubles de l'hôte, ex: stress (Ex: *Prevotella intermedia* - Pi, *Fusobacterium nucleatum* - Fn).

Architecture du Biofilm Sous-Gingival :
- Couche attachée à la racine : Bactéries G+ (anaérobies facultatives).
- Zone superficielle : [Ref: N°5, N°42] Flore spécifique à chaque pathologie, recouverte d'une zone de bacilles anaérobies à G-.

Classification Bactérienne Clé :
- Bacilles G- Anaérobies Stricts : *Porphyromonas gingivalis* (Pg), *Prevotella intermedia* (Pi), *Fusobacterium nucleatum* (Fn), *Campylobacter rectus* (Cr).
- Capnophiles : *Actinomyces actinomycetemcomitans* (Aa), *Escherichia coli* (Ec), *Capnocytophaga*.

Sensibilité Générale :
La flore buccale est sensible aux β-lactamines (mais usage prolongé = mycose). Macrolides = bien tolérés. Imidazoles = actifs sur anaérobies (en association).



Dentist Web

Critères de Choix - Pharmacocinétiques & Terrain Physiologique

Critères Pharmacocinétiques (Les 3 Processus) :

1. **Résorption digestive** : Voie per os.
2. **Distribution** : Compartiments vasculaires (doit pénétrer à concentration efficace dans le tissu).
3. **Élimination** : Active (rénale/hépatique) ou Dégradée (biotransformation hépatique).

Terrain Physiologique Modifié (Posologies & Contre-indications) :

Enfant

[Predicted - Pediatric dosage trap]
Posologie stricte adaptée au poids = 50 mg / kg / jour.

Sujet Âgé

Diminuer les doses du 1/3.
Préférence voie parentérale.

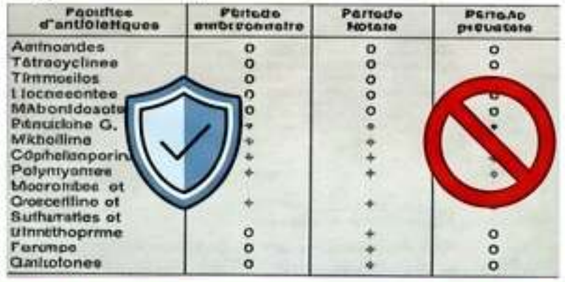
✅ **Recommandés** : β-lactamines, Spiramycines.

❌ **À proscrire** : Phénicoles, Clindamycines.

Femme Enceinte

Ordre de prescription :

1. **Amoxicilline**
2. **Macrolides**
3. Métronidazole
4. **Amoxicilline + Acide clavulanique** (Augmentin).



Famille d'antibiotiques	Période embryonnaire	Période fétale	Période périnatale
Aminosides	0	0	0
Tétracyclines	0	0	0
Trimethoprime	0	0	0
Lincosamides	0	0	0
Métronidazole	0	0	0
Pénicilline G	+	+	+
Mikamycine	+	+	+
Céphalosporines	+	+	+
Polymyxines	+	+	+
Macrolides et Azalides et Lincosamides et Sulfamides et Nitrofurantoïne	+	+	+
Fosfomycine	0	+	0
Fluoroquinolones	0	+	0
Quinolones	0	+	0

[Predicted - Teratogenic risk]
Les Tétracyclines doivent être évitées

Dentist Web

Critères de **Choix** - Terrain Pathologique & Écologique

Cardiopathies (Antibioprophylaxie 1h avant) :

Adulte : Amoxicilline 2g per os. (Si allergie β-lactamines : Clindamycine 600mg).

Enfant : Amoxicilline 75 mg/kg. (Si allergie : Clindamycine 15 mg/kg).

Diabète :

Baisse de résistance, fragilité, perméabilité vasculaire.

ATB = Macrolides (Spiramycines 6-9 MU pdt 5j) ou β-lactamines (Amoxicilline 2g/j pdt 5-7j).

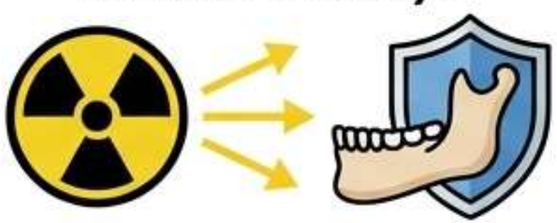
Insuffisance Rénale :

Penicilline G, Amox ou Macrolides à doses réduites.

Insuffisance Hépatique :

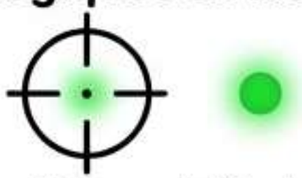
[Predicted - Liver CI] Éviter Tétracyclines et Macrolides (clindamycine, spiramycine).

Radiothérapie (sphère cervico-faciale) :



Risque d'Ostéo-Radio-Nécrose (ORN). ATB imposée : Lincomycine 600mg (1h avant l'acte).

Critères Écologiques & Allergies :



En 1ère intention, privilégier le spectre étroit (Pénicillines G/V/M, Macrolides) pour réduire la pression de sélection.

Allergies : Ne jamais prescrire la même famille si antécédent.

Critères Toxicologiques : Éviter les molécules à toxicités graves pour une simple infection locale.

Dentist Web

Modalités d'Administration : Voie Générale - Les Cyclines

Monothérapie : Les Cyclines (Tétracyclines)

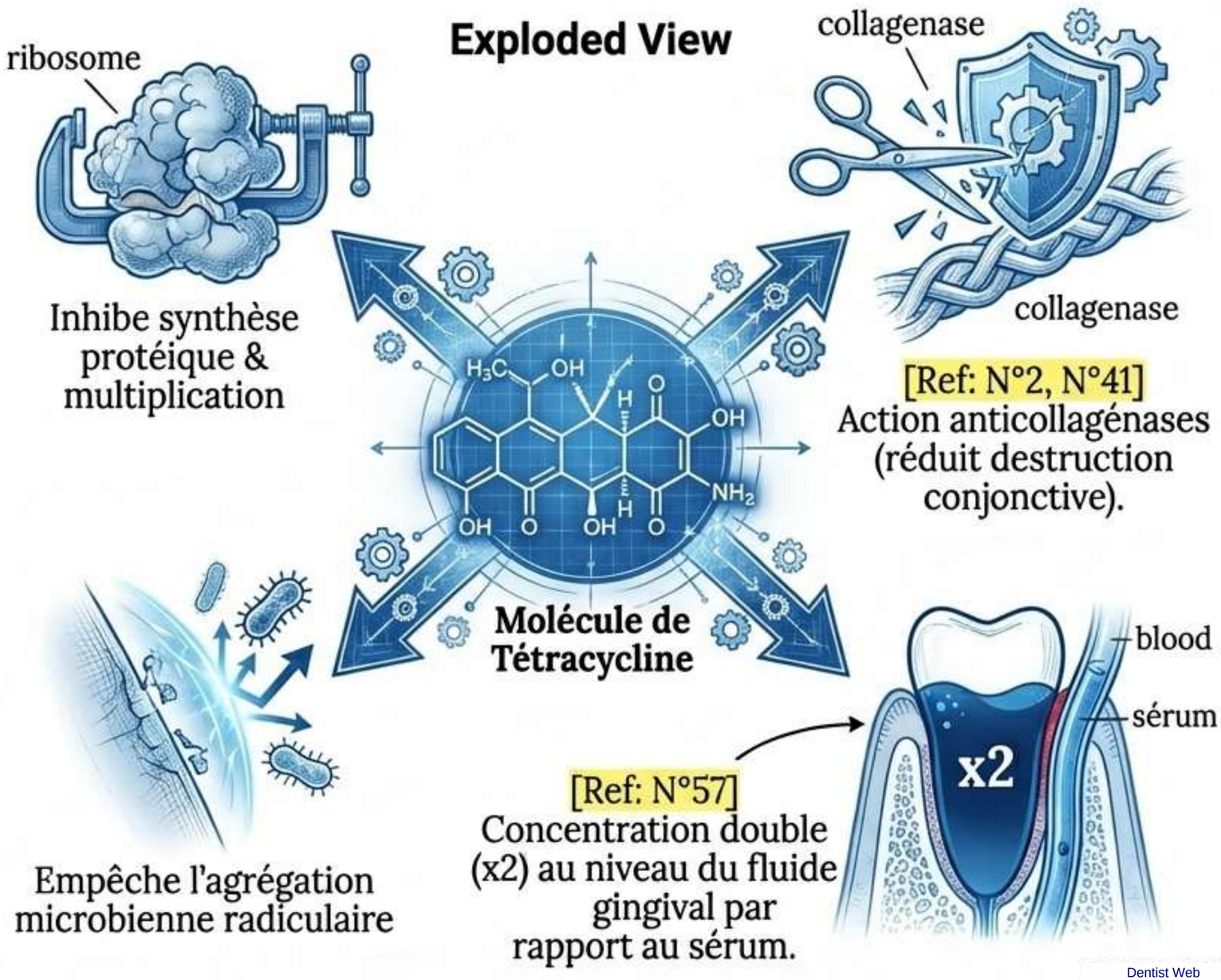
Mécanisme : [Ref: N°41, N°52] Antibiotiques à potentialité bactériostatique. Inhibent la synthèse protéique et s'opposent à la multiplication cellulaire.

Spectre : Actifs sur Aa, Pg, Pi.

Indications : Abcès sévères et [Ref: N°10] Parodontite Agressive Localisée.

Posologies :

- **Chlorhydrate de Tétracycline** : 250mg 1x/j (2 à 3 semaines).
- **Doxycycline** : 200mg/j les 2 premiers jours, puis 100mg/j pdt 12 jours.
- **Minocycline** : 100mg 2x/j.



Dentist Web

Monothérapies Systémiques : Le Standard des Anaérobies

Le Métronidazole

Mécanisme : [Ref: N°54, N°4, N°14] Considéré comme un antibiotique BACTÉRICIDE (destructure l'ADN). Demi-vie longue (10-12h). Excellente diffusion tissulaire, salivaire et fluide gingival.

Cibles : [Ref: N°54] Actif sur Pg, spirochètes, anaérobies stricts. INACTIF sur Aa seul (aérobie facultative).

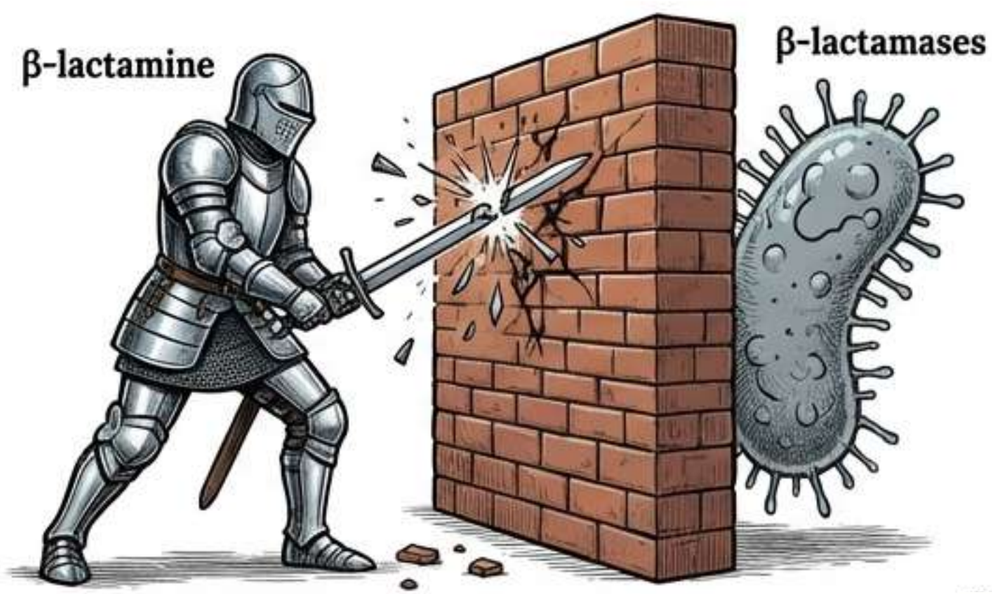
Indications & Posologie : [Ref: N°6, N°72] Molécule de choix pour GUN et PUN. Flagyl 250mg 3x/jour pendant 7 à 20 jours. (Adulte : 750 à 1g/j. Enfant : 30-40mg/kg/j).

Les β-Lactamines & Macrolides

Mécanisme (β-Lactamines) : [Ref: N°46, N°52] Antibiotiques Bactéricides (provoquent lyse cellulaire en inhibant la paroi). Spectre large (G+ et G-).

Problème Clinique : [Ref: N°46] Peu utilisés en monothérapie en parodontie car inefficaces seuls sur de nombreux germes anaérobies (G-) producteurs de β-lactamases (résistance).

Macrolides : (Érythromycine, Spiramycine) Peu utilisées en monothérapie stricte, souvent combinées.



Dentist Web

Antibiothérapie : La Stratégie des Associations

Objectifs des Associations :

[Ref : N°50] 1. Élargir le spectre microbien. 2. Prescrire des doses plus faibles. 3. Exploiter la synergie.

1

Pdt 7-10j. [Ref: N°10, N°17] Traitement de choix de la Parodontite Agressive (Généralisée ou Localisée - Classification Armitage).

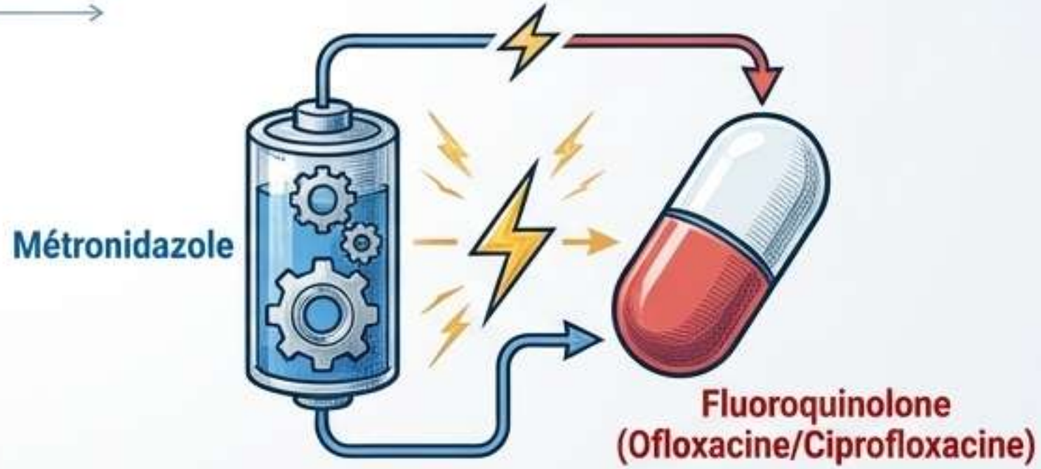
2

Amoxicilline + Acide Clavulanique (Augmentin 250mg/500mg) : [Ref: N°11] L'acide clavulanique inhibe l'action des β-lactamases, rendant la β-lactamine efficace contre Pg, Pi, Fn. Indiqué pour Parodontites réfractaires et GUN.

3

Métronidazole + Spiramycine (Rodogyl / Orogyl) : Actif sur la double menace. Dose : 2g/jour pendant 10 jours.

4



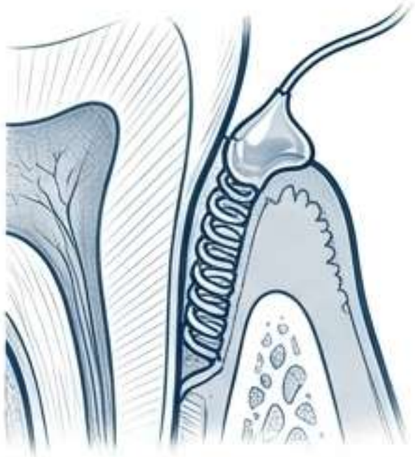
Métronidazole + Fluoroquinolone : Le Métronidazole potentialise la fluoroquinolone. Ofloxacine (400mg/j) ou Ciprofloxacine (1g/j) + Metr

Dentist Web

Antibiothérapie Par Voie Locale (Libération Lente)

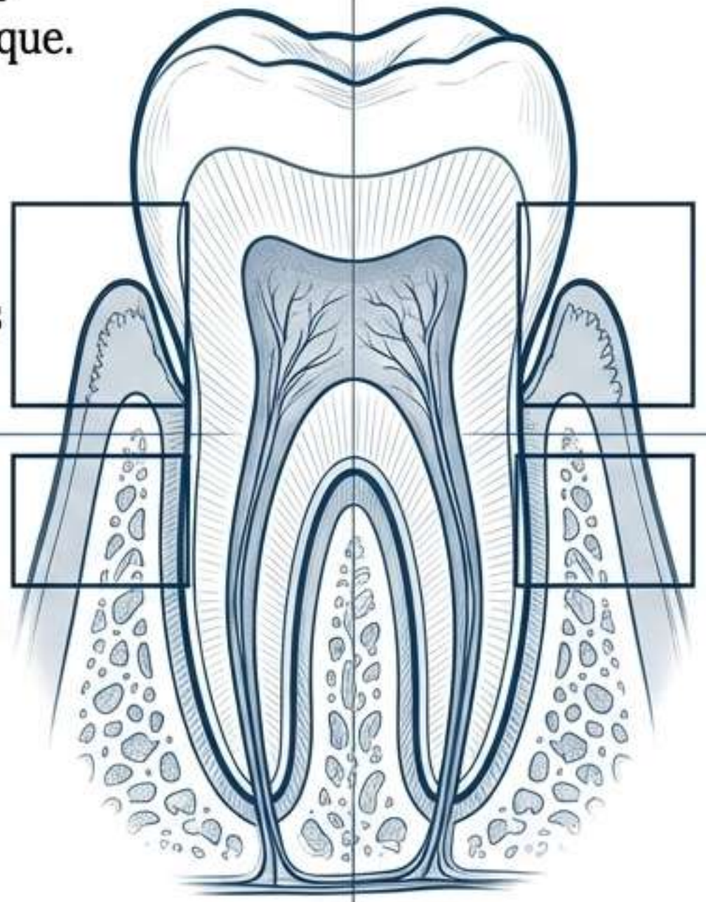
Permet de maintenir une concentration tissulaire élevée sans toxicité systémique.

1. Actisite (Alza)



Fil de Tétracycline fixé avec colle cyanoacrylique. Le patient ne doit pas brosser le site.

Libère 3mg dès 3h. Concentration = 1300 mg/ml pdt 10 jours (vs 1g per os).

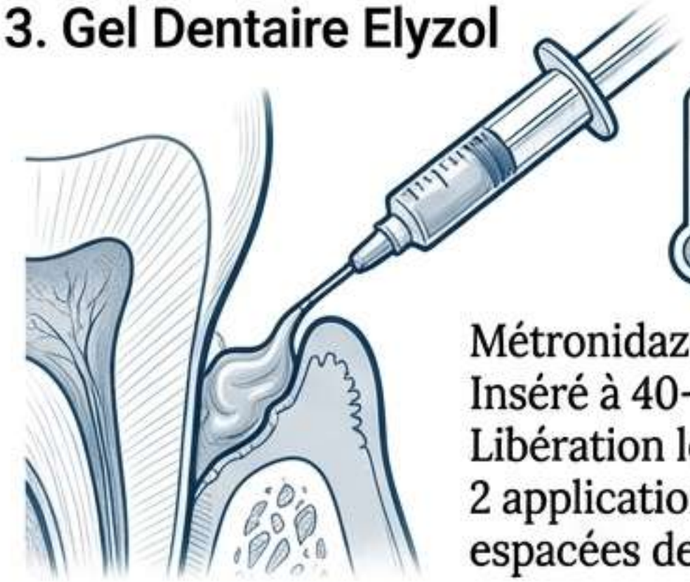


2. Métrogène

Métronidazole à 5% sur éponge de collagène (85%).

Diminue significativement la profondeur des poches (cas réfractaires).

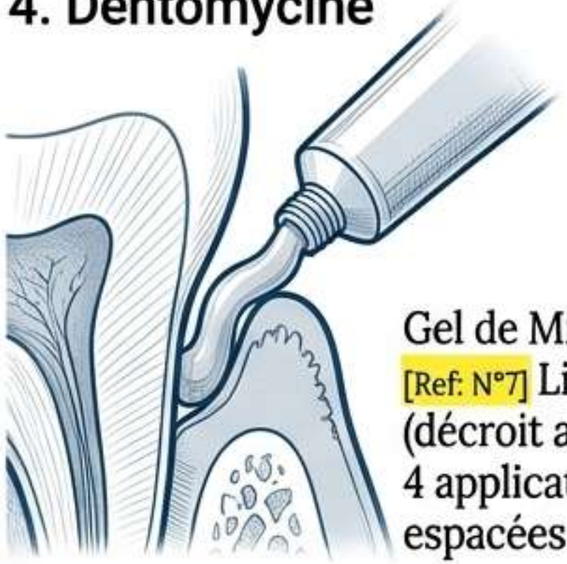
3. Gel Dentaire Elyzol



40-45°C

Métronidazole à 25%. Inséré à 40-45°C. Libération lente. 2 applications/semaine espacées de 7 jours.

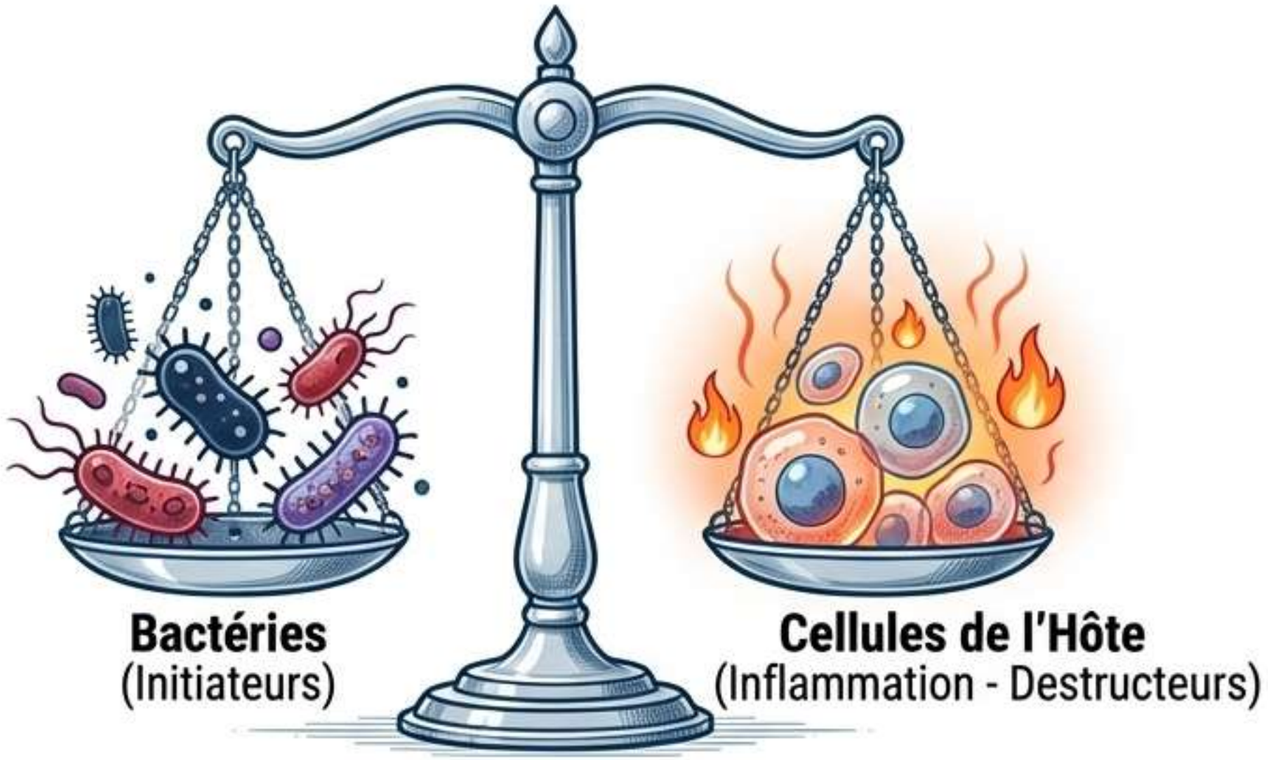
4. Dentomycine



Gel de Minocycline à 2%. [Ref: N°7] Libération prolongée (décroit au bout de 24h). 4 applications par semaine espacées de 14 jours.

Dentist Web

Maladie Parodontale, AINS & Urgences Médicales



Maladie Parodontale & AINS (Le dilemme clinique) :

[Ref: N°4, N°19] Les AINS agissent sur le métabolisme des prostaglandines. Propriétés : Antalgique, Antipyrétique, Anti-inflammatoire, Anti-agrégant. Ils diminuent la perte osseuse et sont prescrits post-chirurgie.

LA CONTRE-INDICATION MAJEURE : Obtenir un effet anti-parodontite nécessiterait une administration continue répétée. En raison des graves effets indésirables, il est **CONTRE-INDIQUÉ** d'utiliser les AINS comme traitement causal des maladies parodontales.

Situations d'Urgences Médicales :

Algorithme douleur de TMJ

Dysfonctionnement de l'ATM
(Douleur)

↓

1ère intention :
Antalgique ou Myorelaxant

↓ **Si échec**
(Douleur persiste)

2ème intention :
Adjoindre AINS ou Corticoïdes

Allergies Graves (au cabinet) :
Utiliser les propriétés antiallergiques des Corticoïdes (AIS).

Dentist Web

Pharmacopée : Anti-Inflammatoires & Enzymes

Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS)		- **Apranax (Naproxène sodique)** : Douleurs articulaires/musculaires/post-op. Adult 1/2 à 2 Cp de 550mg/j. - **Diclofenac** : Douleurs post-op (Cp 50mg, Inj 75mg) ou Gel 1% (massages 3-4x/j sur ATM/muscles). >15 ans. - **Acide Niflurique** : 3% en pommade. - **Indométacine (Indomet 25mg)** : Inflammation synoviale, œdème post-chirurgie osseuse (1 à 4 gélules).
Anti-Inflammatoires Stéroïdiens (AIS)		- **Kenalog** (Acétonide de Triamcinolone 0.1%) : Topique pour lésions muqueuses aiguës/chroniques. 4x/jour après repas. - **Oropivalone** : Stomatites, affections traumatiques bouche. 1 à 4 Cp à sucer.
Enzymes (Immunostimulants & Antiseptiques)		- **Imudon** : Immunostimulant, lyse bactéries (Strep, Fn, Staph). Pour aphtes. 6 à 8 Cp/j pdt 6-8 jours. - **Lyso 6** : Antiseptique sublingual pour petites plaies. 6 à 8 Cp/j à >1h d'intervalle.

Dentist Web

Antalgiques Périphériques (Non-Morphiniques)

La Douleur : Stimulus nociceptif (signal d'alarme). Aiguë/subaiguë/chronique.

Antalgiques Périphériques : Médicaments symptomatiques (ne traitent pas la cause). Douleurs légères à moyennes. Pas de tolérance/dépendance. Différents des anesthésiques (qui causent perte de sensibilité).

	FAMILLE	NOM	ACTION	CONTRE INDICATION	EFFETS SECONDAIRES
WARNING	Acide acétylsalicylique	Aspégic / Catalgine	Antalgique, antipyrétique	Ulcère, grossesse, allergie, AVK, métrorragie	Troubles digestifs, syndrome hémorragique, hépatite, céphalées, acouphènes.
	Paracétamol	Doliprane / Dafalgan	Antalgique, antipyrétique	Hépatopathie, alcoolisme, dénutrition, IR	[Predicted - Toxicité] Surdosage (>10g) = risque de cytolyse hépatique. Antidote = Fluimicil.
< 15 ans	Noramidopyrine	Novalgine / Pyréthane	Antalgique	< 15 ans, hypersensibilité, porphyrie hépatique.	Agranulocytose, coloration brune des urines, IR aiguë, asthme.

Dérivés Salicylés : Ibuprofène, Kétoprofène (Antalgiques + Antipyrétiques + AINS).

Dentist Web

Antalgiques Morphiniques & L'Échelle de l'OMS

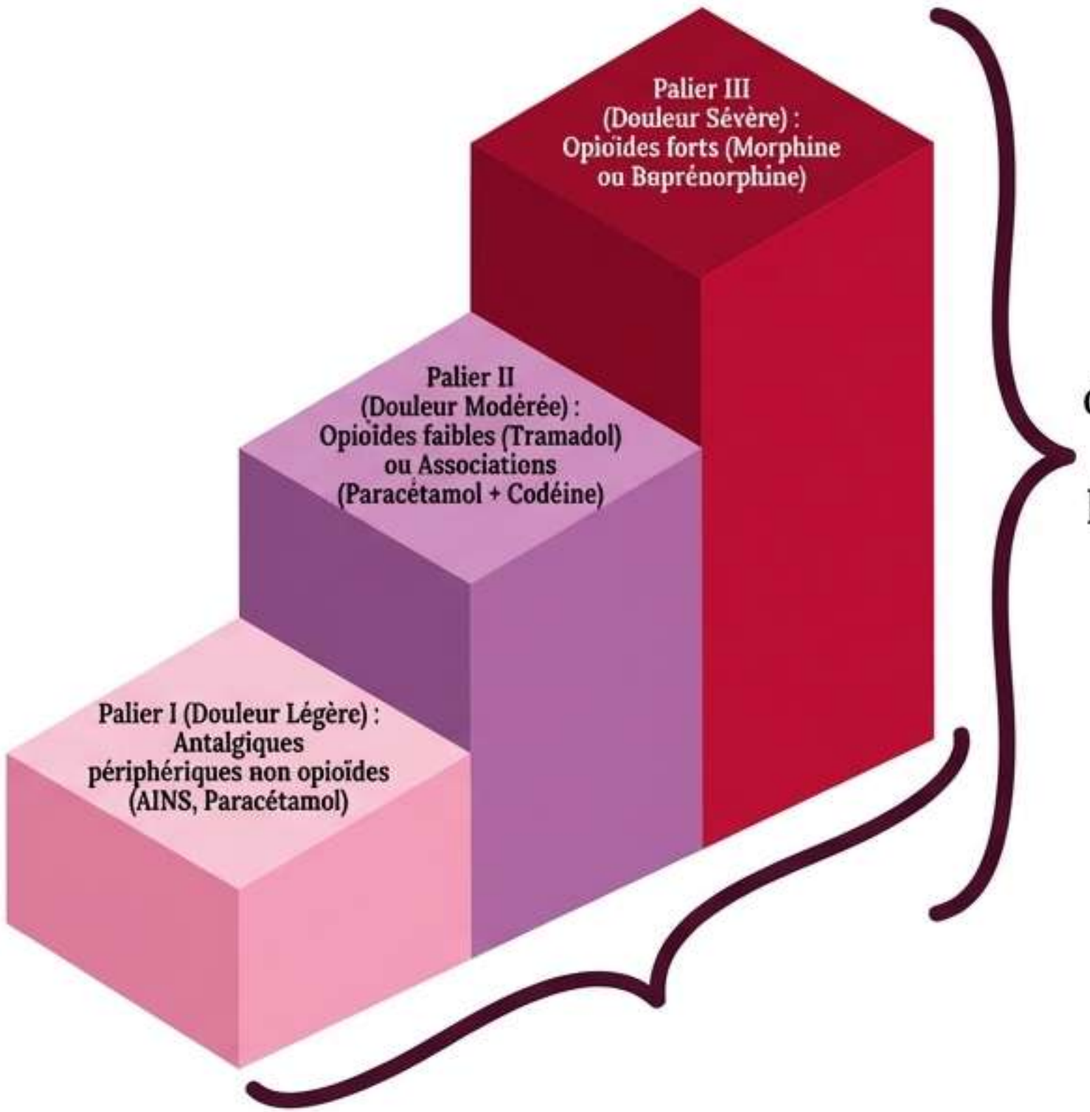
Les Dérivés Morphiniques :

Conçus pour conserver l'analgésie de la morphine tout en limitant ses lourds effets indésirables.

Morphiniques Mineurs :

- Codéine Seule (Dicodin) : CI = Asthme, IR, hypothyroïdie, <15 ans. ES = Constipation, bronchospasme, somnolence, dépendance/sevrage.

- Codéine + Paracétamol (Efferalgan Codéiné) : Cumule les CI/ES de la codéine + rares thrombopénies.



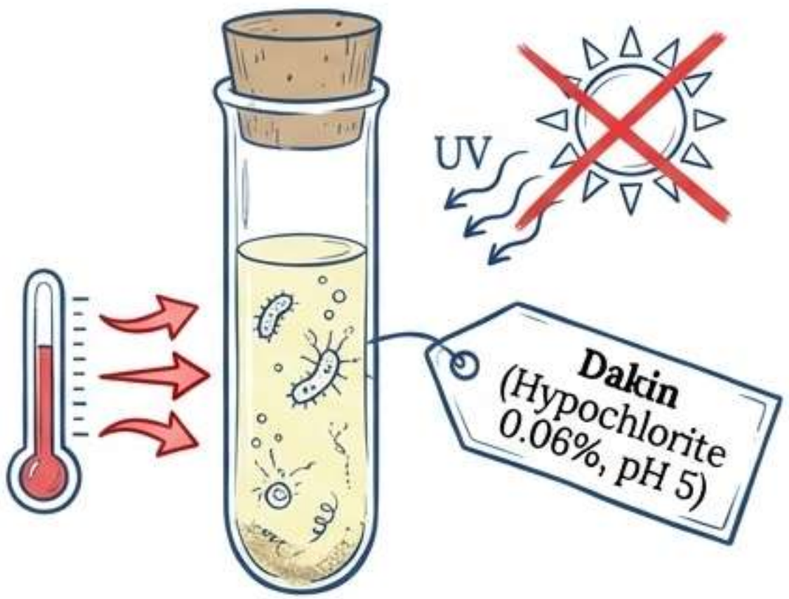
Possibilité d'ajouter des AINS ou Paracétamol à chaque palier.

Dentist Web

L'Arsenal Antiseptique : Halogénés & Biguanides

Les Antiseptiques : Inactivent virus et détruisent micro-organismes sur tissus vivants (action en traversant la paroi/détruisant les protéines).

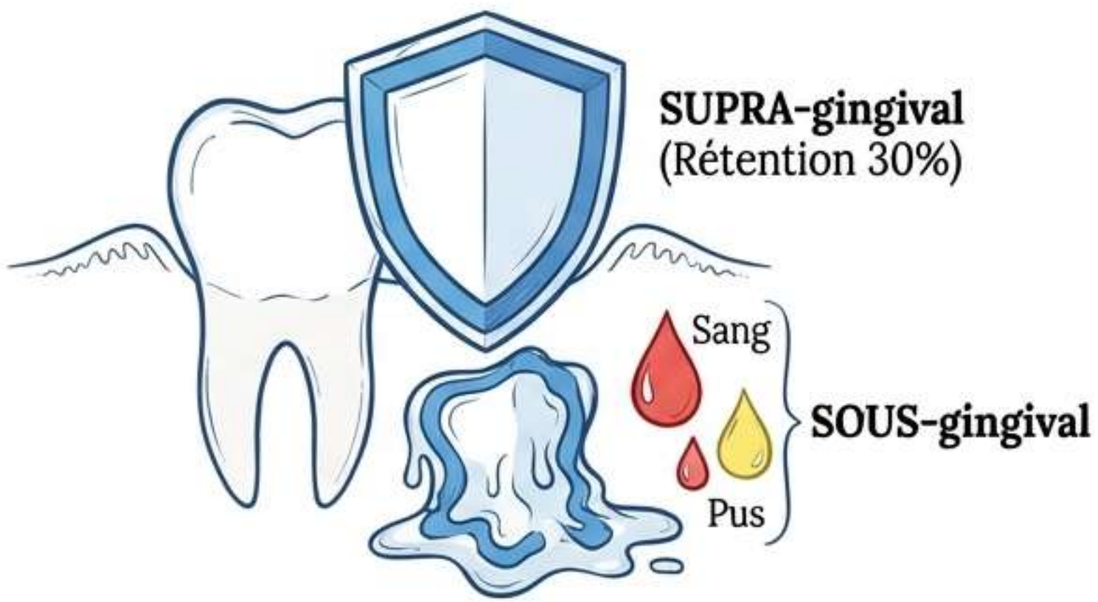
Halogénés - Produits Chlorés (Ex: Dakin)



Spectre : Bactéries, champignons, virus, spores. Péremption courte.

[Predicted - Conditions de stabilité] Si pH<5 = gaz chloré (inactif). Action max à pH=5. Chaleur accélère l'action mais détruit la stabilité. Inactivé par savons, matières organiques, minéraux et UV.

Biguanides - Chlorhexidine (0.12% - 0.2%)



[Ref: N°8, N°16] Bactéricide large spectre. Altère la paroi (lyse). Haute rétention. C'est le standard en SUPRA-gingival.

Limite Critique : [Ref: N°11] Rapidement INACTIVÉE en SOUS-gingival par le sang, le pus, Pg, et certains anions (dentifrice).

CI absolue : Oreille interne (surdité neurosensorielle).

Dentist Web

Synthèse Clinique & Autres Antiseptiques

Autres Familles d'Antiseptiques :
- **Ammonium Quaternaires (Cetylpyridinium)** : Inactivés par matières organiques et savons. Nécessite 4 bains/jour.
- **Oxydants (Eau oxygénée - H2O2)** : [Predicted] Indiqué pour GUNA (délabrements nécrotiques). Irritant >30%.
- **Sels Métalliques** : Citrate de zinc. **Héxétidine** : [Ref: N°16] Inefficace à long terme car aucune capacité de rétention buccale.
- **Composés Phénolés (Listerine)** : Extrait les LPS des bactéries G-.

SYNTHÈSE CLINIQUE : Lequel arrête la Parodontite ? (L'Affrontement Sous-Gingival)

CHLORHEXIDINE

Échec sous-gingival (inactivée par sang/pus).
Récupération du niveau infectieux de départ à 31 jours.

IODE (Bétadine 10% / Povidone 0.05%)

[Ref: N°11, N°19] **Antiseptique de RÉFÉRENCE en sous-gingival. Efficacité persistante malgré le sang. Usage curatif (JAMAIS prophylaxie).**
Succès sous-gingival : Une seule irrigation diminue durablement les spirochètes.

CI Iode: Allergie, Grossesse (2e/3e trim), allaitement, nouveau-né.

Dentist Web

Exam Pattern Analysis (Analyse des Récurrences)

Sujets les plus répétés (Très Haute Probabilité) :

- Top 1 - Le Métronidazole : Souvent testé sur sa nature BACTÉRICIDE (non bactériostatique), son inefficacité sur sur Aa seul, et son rôle royal dans les GUN/PUN.

- Top 2 - Le Piège Sous-Gingival (CHX vs Iode) : L'inactivation de la CHX par le sang/pus fait de l'Iode la seule bonne réponse en sous-gingival.

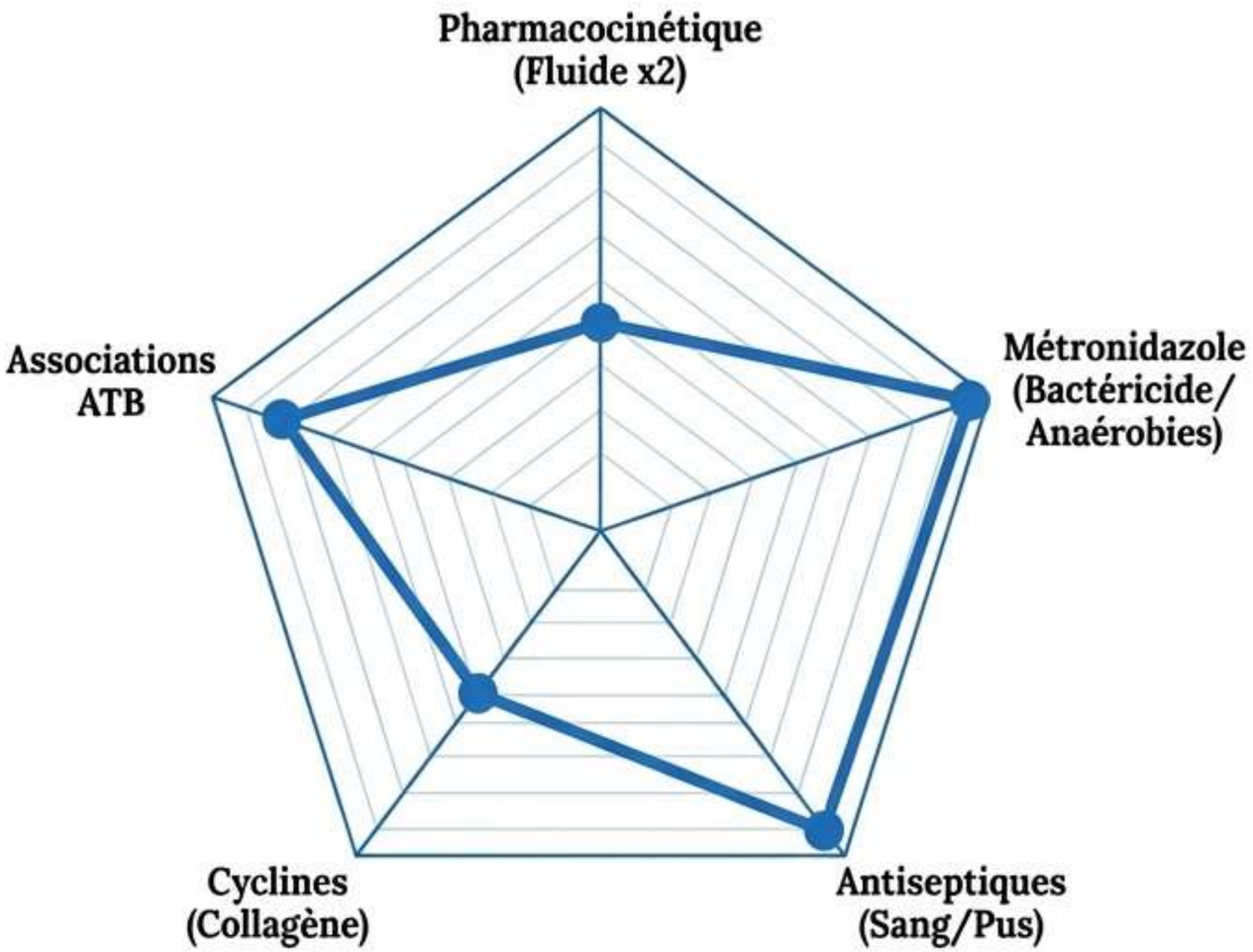
- Top 3 - L'Architecture des Cyclines : Nature bactériostatique, effet anticollagénase, et le piège de leur concentration x2 dans le fluide gingival.

- Top 4 - Associations Stratégiques : Amoxicilline + Acide Clavulanique contre les β-lactamases ; Amoxicilline + Métronidazole pour Parodontite Agressive.

Zones d'ombres (Futures cibles potentielles) :

Les toxicités systémiques croisées (Tétracycline interdite grossesse/foie, Paracétamol toxique foie >10g) et les paramètres du Dakin (pH 5).

Indice de Prédiction : 95%



Dentist Web

Final Mind Map : La Matrice Décisionnelle Parodontale

Prescription Parodontale

Antibiothérapie Systémique

- Métronidazole : Bactéricide, Anaérobies purs (Pg, Pi), GUN/PUN.
- Cyclines : Bactériostatiques, Fluide x2, Anti-Collagénase.
- Associations : Amox+Metro (Agressive), Amox+Ac.Clav (Réfractaire/β-lactamases).

Antibiothérapie Locale

- Actisite : Tétracycline (3h -> 10j, 1300mg/ml).
- Elyzol / Métrogène : Métronidazole.

Gestion de l'Inflammation & Douleur

- AINS : Post-Op, Diminue perte osseuse. CI en traitement continu.
- Antalgiques : Paliers OMS (I: Para/AINS -> II: Codéine -> III: Morphine).

L'Arsenal Antiseptique

- Supra-Gingival : Chlorhexidine (Rémanence 30%).
- Sous-Gingival : Iode 0.05% (Résiste au sang/pus).

Dentist Web